

### Información Paciente

**Nombre** : Jose Ernesto Alarcon Gonzalez

**Rut** : 5.578.536-8

**N° Archivo** : A435067

**N° Epicrisis**

**298866**

**Edad** : 79a 2m 21d

**Fecha Nacto**: 19/12/1942

**Sexo** : Masculino

**Dirección** : 8 Sur 1990

**Comuna** : La Granja

**Teléfono** : 9 9526 4881

### Información Hospitalización

**Unidad de Ingreso** : Upc - Uci Adulto

**Fecha Ingreso** : 07/02/2022 00:45

**Días Estadía**: 33

**Unidad de Egreso** : Utac/ Utinx

**Fecha Egreso** : 12/03/2022 01:03

### Motivo o Diagnóstico de Ingreso

HIDROCEFALIA

### Comorbilidades

### Procedimientos

### Intervenciones Quirúrgicas

### Epidemiología

### Resumen Clínico

Paciente con antecedentes descritos consulta el día 05/02/22 en HPH por cuadro de 2 días de deterioro de conciencia y dolor abdominal. Evaluado por Cx se pesquisa mediante tac de abdomen y pelvis quiste abdominal el cual es drenado con salida de líquido de aproximadamente 3.5 litros mejorando conciencia. Se realiza tac de cerebro (previo a drenaje abdominal) que muestra ventriculomegalia. Sin corrección posterior a drenaje abdominal. Se retira DVP e instala DVE.

Se mantiene hospitalizado en UCI hasta 14/02, se traslada extubado sin requerimiento O2 ni soporte ventilatorio a UTI Ncx. Sin complicaciones infecciosas demostradas. Recibe ceftriaxona en dosis meníngeas de manera empírica.

Durante estadía en UTINcx paciente con HC (+) persistente para S. Epidermidis por lo que se mantiene con vancomicina/meropenem. Con disminución de débito DVE se decide reintervención Qx 4/3/22 am para recambio de DVE. Sin incidentes. Durante el día nuevamente se ocluye DVE con salida de material hemático leve se decide nuevamente resolución quirúrgica con cambio de DVE y instalación en lado contra lateral. Procedimiento sin incidentes, pero sale recuperación en VMI con NAD > 0.3. Logra estabilizarse, trasladándose el 10.03 a UTIN.

En unidad progresa séptico, foco no identificable, se mantuvo con Vancomicina, además, de DVE escaso débito. Ante gravedad, se conversa con familia decidiendo en conjunto no innovar en terapia y no someter a más procedimientos invasivos. Paciente fallece el 12/03 a las 01:21. Se notifica a familia y a neurocirujano de turno.

### Diagnóstico de Egreso

HIDROCEFALO - Hidrocefalia crónica

Sepsis, no especificada - Hidrocefalia, DVE obstruido

### Condición de Egreso

Traslado

**Egreso con Catéter Doble J:NO**

Paciente extubado ayer 11:00, weaning consolidado, con O2 3L por naricera. Sin DVA, sin fiebre, obedecer órdenes simples.

### Plan Post Alta

1)HDN: estable, HCto 30%. Noradrenalina SOS para PAM 70-80 mmHg.

2)Respiratorio: paciente extubado ayer 11:00, weaning consolidado, con O2 3L por naricera. PAFI 583

3) Infeccioso: en tratamiento con vancomicina por cultivos persistentemente (+) para S. Hominis/epidermidis.

**Fecha Epicrisis** : 12/03/2022 01:49

Afebril, parámetros inflamatorios estables. Re evaluar con equipo infectología. Aislamiento por ser portador de Enterococo VAN B.

4) NeuroQx: evaluado por equipo hoy, impresiona en condiciones de traslado a UTI Neurocx.

5) Social: ayer se conversa con familiares proporcionalidad terapéutica donde aceptan NO UCI, NO VMI. Re definir con familiares y tratantes (Neurocirugía) proporcionalidad en caso de deterioro/nuevas interurrencias.

6) Pendiente Traslado a Uti Neurocx

### Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

### Controles

INTERNO

Becado/Residente

Estefanía Meza Fabia  
Médico Tratante (Staff)